

FILAIRES ET FILARIOSES

Dr Belattar.N

Année universitaire 2024/2025

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- **Différencier** les filaires pathogènes des filaires non pathogènes.
- **Evoquer** le diagnostic d'une filariose devant des signes cliniques et biologiques évocateurs.
- **Planifier** une prise en charge thérapeutique adéquate.
- **Proposer** des mesures préventives adaptées.

PLAN

- I. Généralités.**
- II. Classification**
- III. Filarioses lymphatiques**
- IV. Onchocercose**
- V. Loase**

GÉNÉRALITÉS

- Les filarioses sont des helminthiases largement répandues, transmises souvent par des **arthropodes**.
- Elles font partie des **grandes endémies tropicales** avec plus de **400 millions** personnes infectées dans les régions **tropicales et subtropicales**.
- Elles sont dues à des nématodes filiformes blancs et vivipares vivant dans le système **lymphatique** ou le **tissu sous-cutané**, dénommés: **les filaires**.
- Leurs larves rencontrées dans le **sang**, dans le **tissu sous-cutané** ou **dans le corps même de la filaire** et le **milieu extérieur**, sont appelées: **les microfilaires**.
- Ces nématodoses se traduisent par des tableaux cliniques variables .

GÉNÉRALITÉS

❑ Neuf (09) espèces décrites chez l'Homme se répartissent selon leur impact en santé publique en:

- Filarioses **majeures** (pathogènes)
- Filarioses **mineures** (peu ou pas pathogènes).

❑ On distingue selon la topographie des adultes:

- Filarioses lymphatiques : **Wuchérériose ; Brugiose.**

- Filarioses cutanéodermiques : **Loase ; Onchocercose; filariose de Médine**

Filarioses majeures

Mansanelloses à *M streptocerca*

- Autres: **Mansanelloses (à *M ozzardi* et *M perstans*)**

Filarioses des séreuses

Filarioses mineures

Dirofilarioses (Filarioses animales en impasse chez l'homme)

NB: La **filariose de Médine** ou **dracunculose**, malgré son nom, ne fait pas partie de la famille des filaires stricto sensu

CLASSIFICATION

- **E:** Némathélminthes
 - **C:** Nématodes
 - **O:** Spiruridés
 - **Super F:** Filarioïdés
 - **F:** Filaridés
 - **G:** Wuchereria, Brugia.
 - **Espèces:** *W. bancrofti* et sa variété *pacifica* .
B. malayi (ou filaire de Malaisie)
B. timori.
- F: Onchocercidae
- G: Onchocerca
Loa
- Onchocerca volvulus*
Loa loa

Filarioses lymphatiques

DEFINITION

Les **filarioses lymphatiques** sont:

- des nématodoses **strictement tropicales**.
- engendrées par la présence dans les voies lymphatiques, de 3 espèces de filaires : *Wuchereria bancrofti* et sa variété *pacifica*, *Brugia malayi* et *Brugia timori*.
- transmises par des moustiques *Culicidae* appartenant aux genres : *Culex*, *Aedes*, *Anophèles* et *Mansonia*
- Pouvant être responsables de complications **chroniques** souvent graves principalement: les **éléphantiasis**
- **1,1** milliard de personnes sont exposées dans **80** pays: d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie, dont **120** millions sont infectées et **40** millions d'eux souffrent de difformités et d'invalidités graves.

ÉPIDÉMIOLOGIE

1- Morphologie:

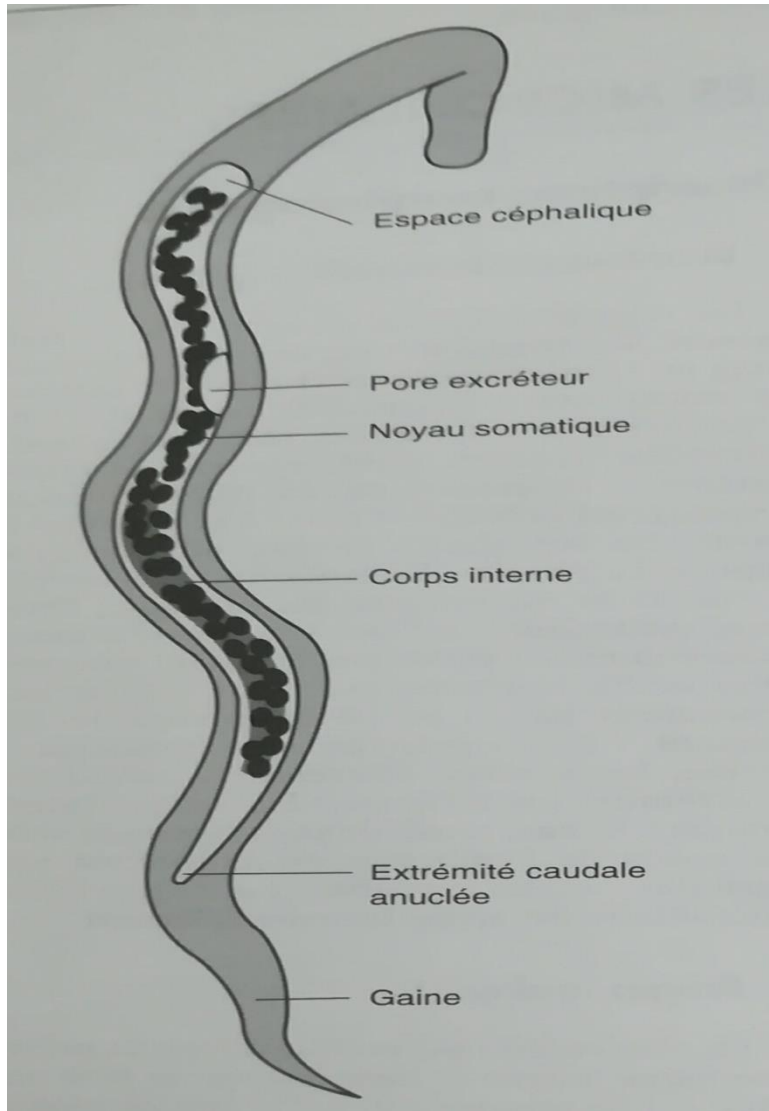
□ Les adultes:

- ✓ Macrofilaires ronds, filiformes, blancs plus au moins translucides.
- ✓ À cuticule lisse, finement striée.
- ✓ L'extrémité caudale arrondie est :
 - rectiligne chez la femelle .
 - recourbée ventralement chez le mâle.
- ✓ L'extrémité antérieure légèrement renflée.
- ✓ Taille: ***W. bancrofti*** est plus grande que ***Brugia sp.***
 - La femelle mesure de **40** à **100** mm de long/**0.2** à **0.3** mm de large.
 - Le mâle mesure **15** à **35** mm de long

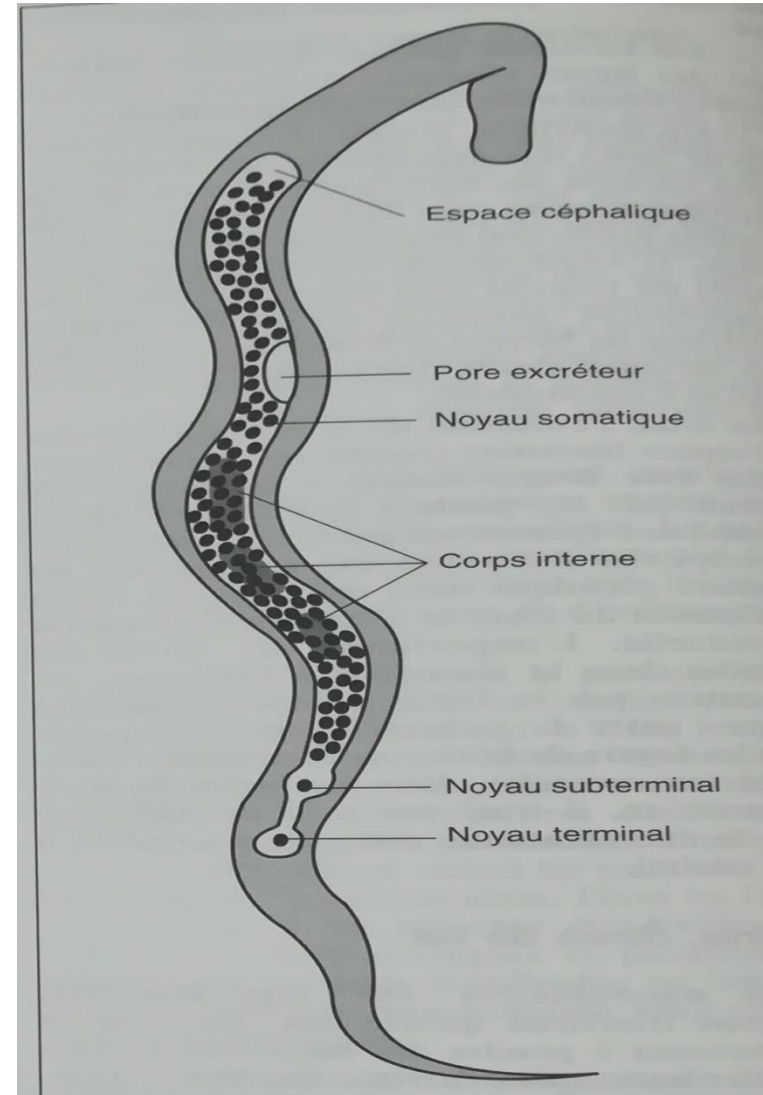
ÉPIDÉMIOLOGIE

□ Les microfilaires:

- Gaine: plus longue que la microfilaire.
- Extrémité antérieure arrondie et postérieure effilée
- Cuticule striée transversalement.
- Le corps interne est bien visible et coloré en rouge vermillon..



Microfilaire de
Wuchereria bancrofti



Microfilaire de
Brugia malayi

ÉPIDÉMIOLOGIE

□ Les microfilaires:

	<i>W. bancrofti</i>	<i>B. malayi</i>	<i>B. timori</i>
Taille	280 à 300μ/7μ	250 à 280μ/ 6 à 8μ	300 μ
Gaine	Longue et plissée Rose au MGG non colorée au Giemsa	Longue Rose au MGG/Giemsa	Non ou peu colorée par Giemsa
Aspect sur les frottis	Courbures larges régulières Allure souple	Courbures irrégulières sinueuses Aspect tortillé	
Extrémité postérieure	Effilée Une seule rangée de noyaux subterminaux	1 noyaux subterminal et 1 terminal Avec deux renflements	5 à 8 noyaux terminaux (le dernier est très petit)

ÉPIDÉMIOLOGIE

□ Les microfilaires:

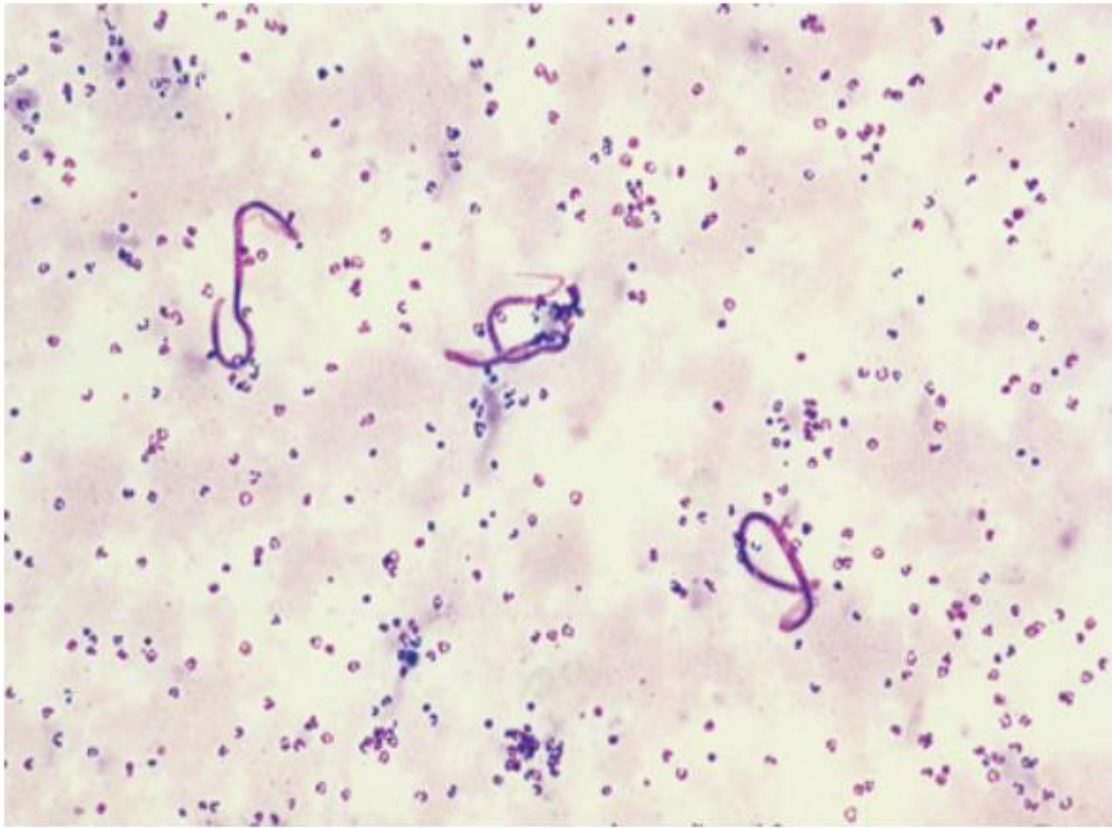
	<i>W. bancrofti</i>	<i>B.malayi</i>	<i>B.Timori</i>
Espace céphalique	Court Aussi large que long	Long Plus long que large	Très long 3 fois plus long que large
Corps interne	Bien visible, dans la 2ème moitié du corps unique, allongé	visible Divisé en 3 masses	
Noyaux somatiques	Petits, ronds, séparés	Petits, Ovoïdes, serrés et se chevauchant	



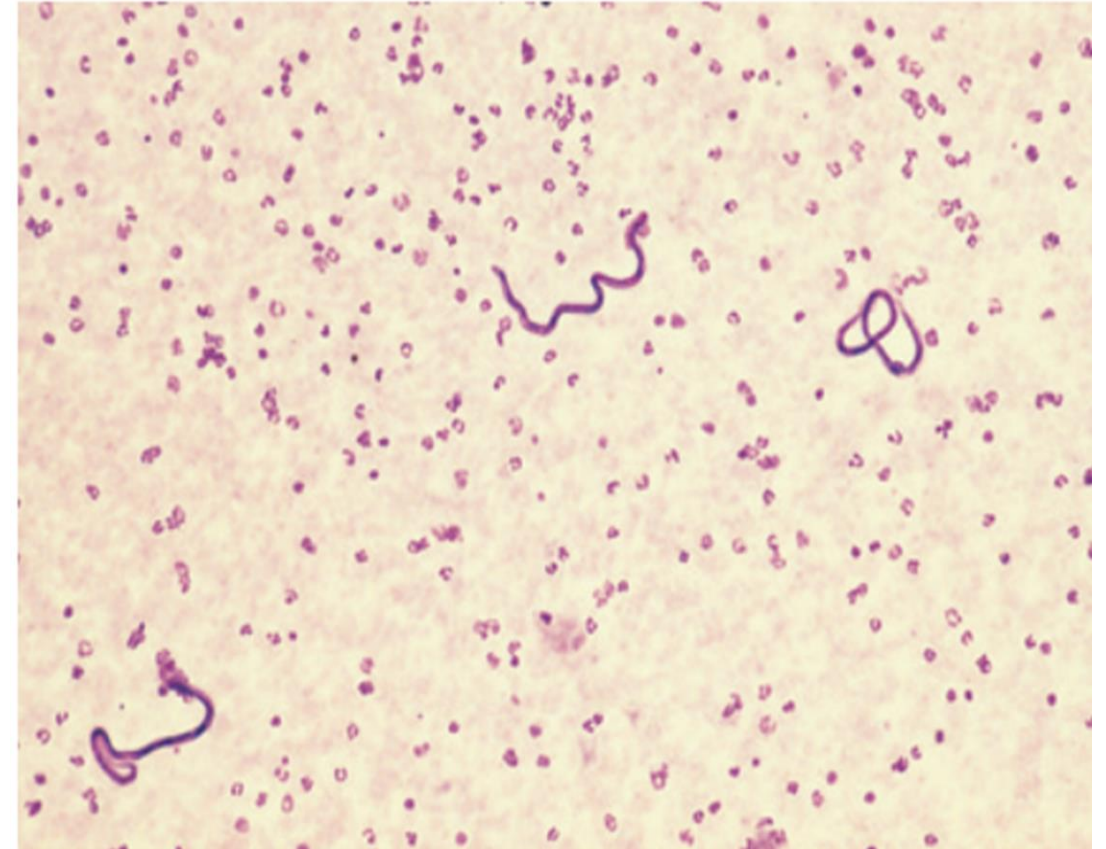
***Wuchereria bancrofti* : microfilaire**



***Brugia malayi* : microfilaire**



Microfilaires de ***W.bancrofti*** en goutte épaisse; courbures régulières; gaine visible. Coloration MGG objX10.



Microfilaires ***B.malayi***. Goutte épaisse; courbures irrégulières. Coloration MGG objX10.

ÉPIDÉMIOLOGIE

2-Biologie:

□ Les adultes:

- Localisation: dans la circulation lymphatique (vaisseaux et ganglion).
En particulier: canal thoracique, scrotum, cordon spermatique, lymphatiques des membres inférieurs et de l'abdomen...
- Nutrition: la lymphe (en relarguant des substances très immunogènes).
- Longévité: importante, 8 à 15 ans dans le système lymphatique de l'homme
- Vivipares, les femelles fécondées émettent des microfilaries (300 µ) 2 à 12 mois après l'infestation.

ÉPIDÉMIOLOGIE

□ Les microfilaires:

- Durée de vie dans l'organisme est de quelques mois (***W bancrofti* : 3 à 12 mois**)
- Elles vivent dans la circulation sanguine (sans subir ni mues ni multiplication).
- Uniquement chez le vecteur: transformation des L1 au L2 et L3 (métacycliques infestantes).
(Passage nécessaire pour l'évolution au stade adulte → pas de filariose lymphatique transfusionnel)
- Mobiles (***Wuchereria bancrofti*** est très mobile a l'état frais).
- Les microfilaires: Circulent en permanence dans la lymphe et périodiquement dans le sang.
- Périodicité: Nocturne (Le rythme est parfois subpériodique)

ÉPIDÉMIOLOGIE

- **3- Réservoir:**

C'est principalement l'homme.

- *W. bancrofti*: strictement humaine.
- *B. timori*: homme
- *B. malayi*: homme et nombreux animaux sauvages et domestiques .

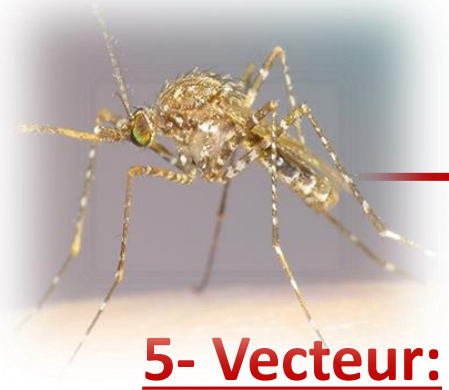
ÉPIDÉMIOLOGIE

4- Mode de transmission:

La transmission est assurée par des piqûres répétées de moustiques femelles infectées.

- *W. bancrofti* est transmise par *Culex*, *Anopheles* et *Aedes*.
- L'espèce *Brugia malayi* est transmise par *Anopheles*, *Aedes* et *Mansonia*.
- L'espèce *Brugia timori* est transmise par *Anopheles*.

ÉPIDÉMIOLOGIE



5- Vecteur:

▪ Classification:

- **E:** *Arthropodes*
- **C:** *Insectes*
- **O:** *Diptères*
- **F:** *Culicidés*
- **S/F:** *Culicinae, Anophélinae;*
- **G:** *Culex +++ Anophèles*
Aedes
Monsonia.



▪ Caractères généraux:

- ✓ Diptères, nématocères.
- ✓ Corps élancé, antennes longues, ailes et pattes longues.
- ✓ Larves vermiformes
- ✓ Seules les **femelles** sont hématoophages

ÉPIDÉMIOLOGIE

6- Cycle évolutif: cycle indirect

homme: hôte définitif et un moustique: hôte intermédiaire

- **Lors d'un repas sanguin,**

Les microfilaires sont absorbées par un moustique lors d'un repas sanguin chez un hôte infesté. Elles se développent dans la musculature thoracique en une forme infectante puis migrent jusqu'à la trompe.

- **Lors d'une piqûre ultérieure,**

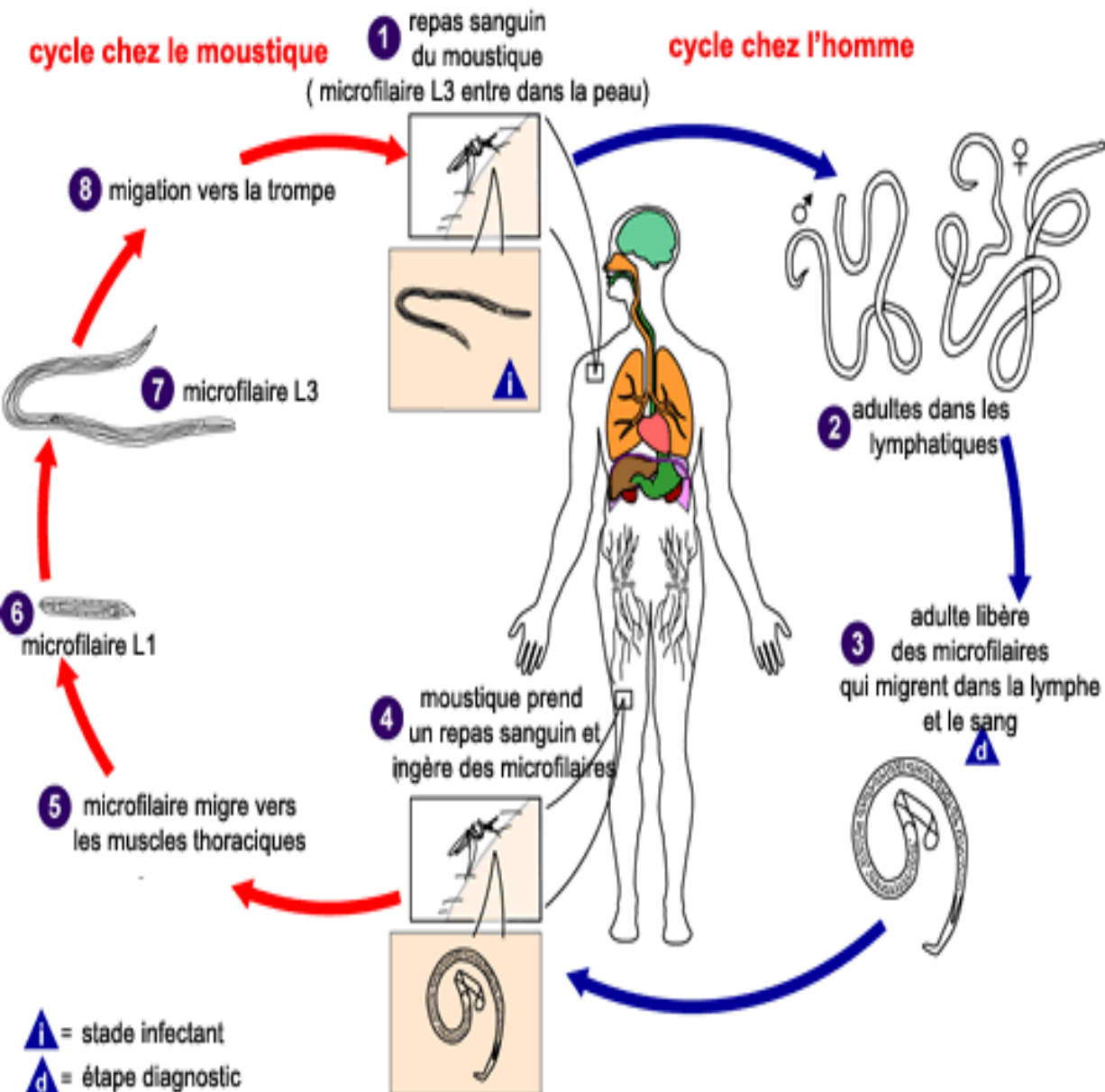
les larves atteignent le système lymphatique où elles continuent leur développement pour devenir des vers adultes mâles et femelles. Après fécondation, la femelle produit jusqu'à

50 000 microfilaires par jour qui passent dans les vaisseaux sanguins.

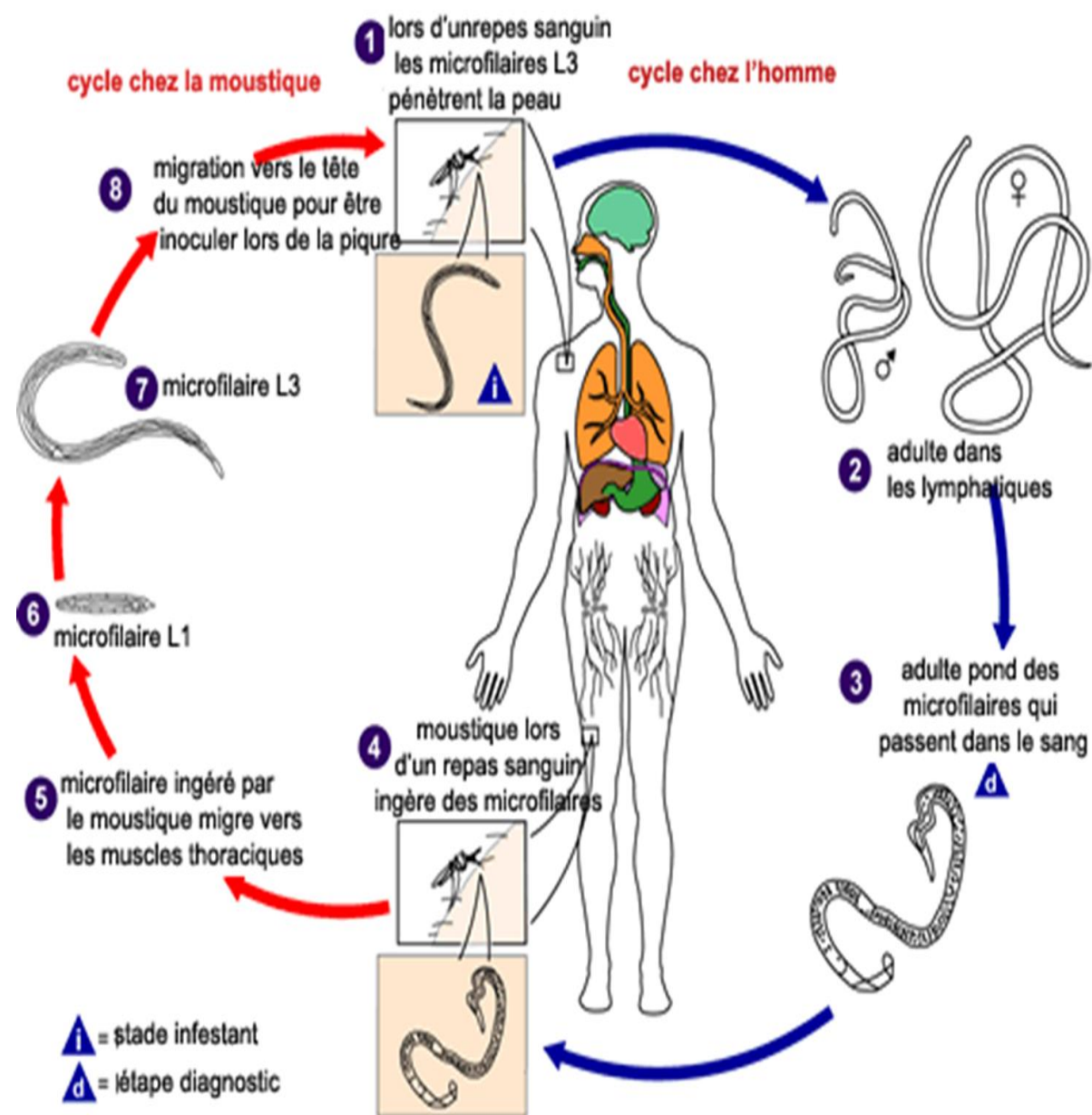
qui vont se retrouver en permanence dans la lymphe et périodiquement dans le sang.

Les microfilaires de *Brugia malayi* et de *Brugia timori* apparaissent dans le sang après **2 à 3** mois et celles de *Wuchereria bancrofti* après **8 à 12** mois

Wuchereria bancrofti



Brugia malayi



ÉPIDÉMIOLOGIE

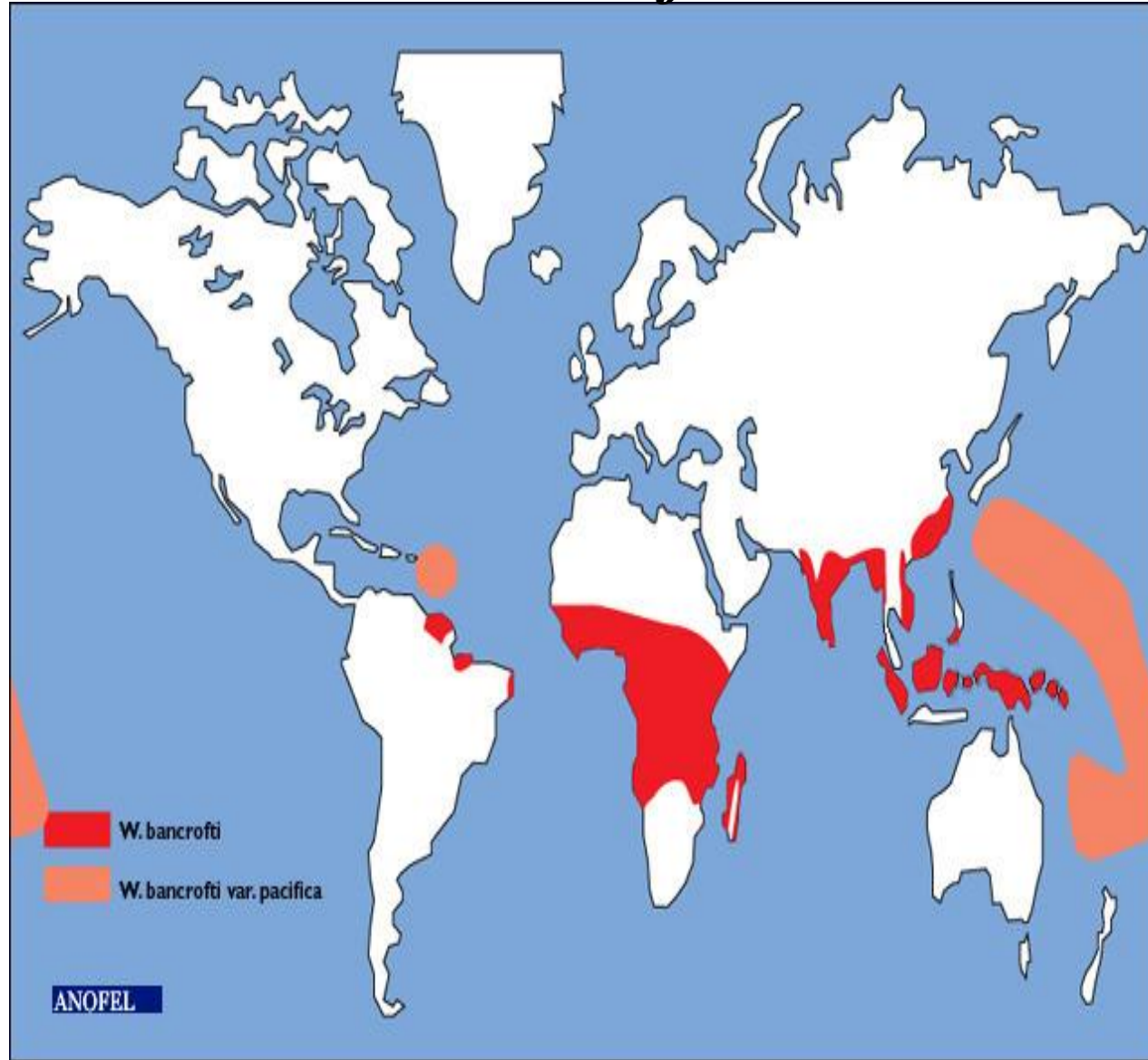
7- Répartition géographique:

- ***Wuchereria bancrofti*** ou **filaire de Bancroft**

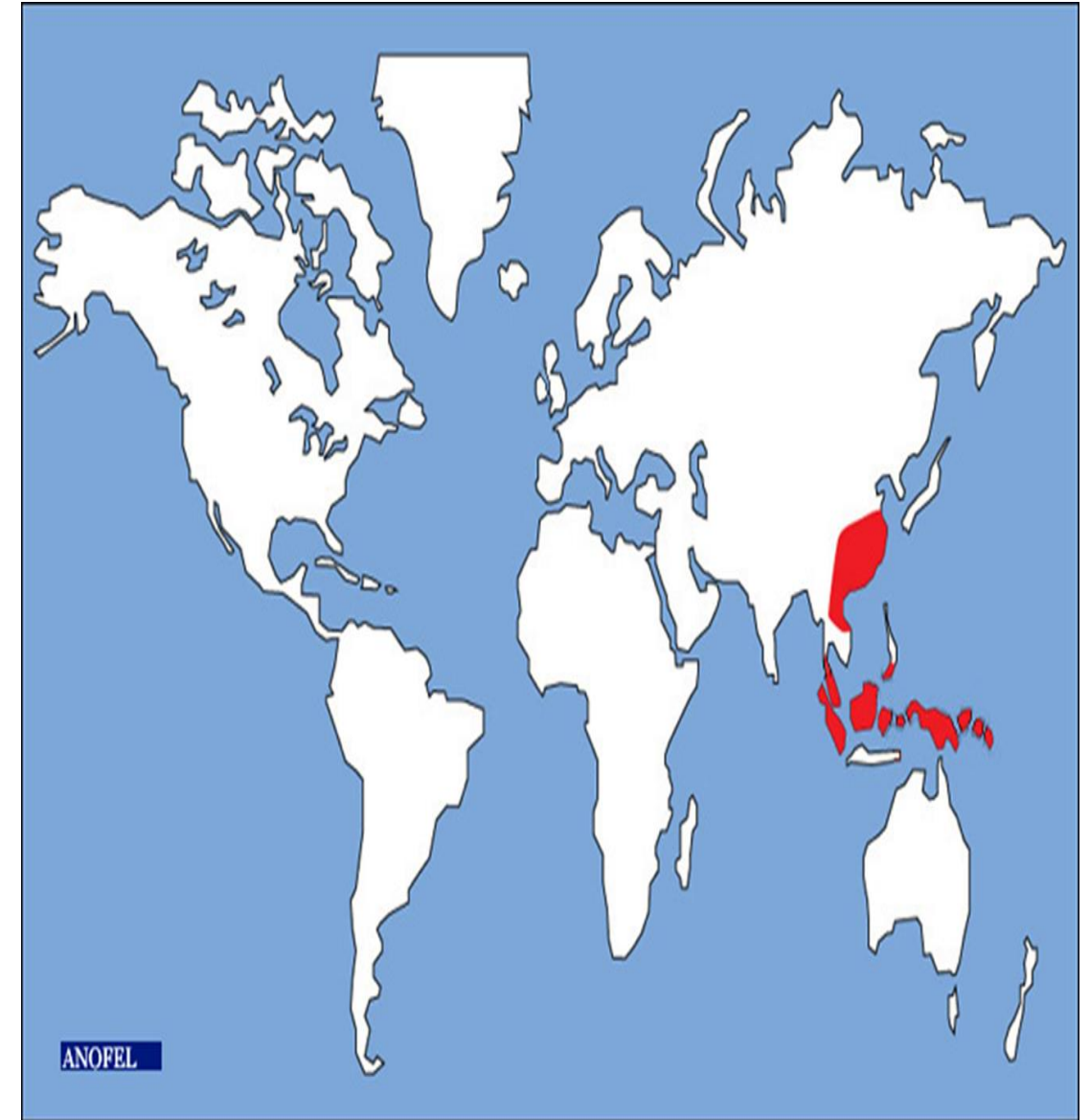
De loin la plus fréquent, **cosmopolite intertropicale**, présente dans tous les continents (sauf l'Europe)

- La variété ***pacifica*** sévit en Océanie.
- ***Brugia malayi*** ou **filaire de Malaisie** est **exclusivement asiatique**
- ***Brugia timori*** ou **filaire de Timor** présente **uniquement en Indonésie**

Répartition géographique *W.bancrofti*



Répartition géographique *B. malayi*



CLINIQUE

❖ L' évolution clinique varie selon

- ❑ l'espèce,
- ❑ l'importance des contaminations
- ❑ et la réponse immunitaire induite chez l'hôte

1/ formes asymptomatiques:

En zone d'endémie, les formes asymptomatiques sont fréquentes avec ou sans microfilariémie

- Les porteurs sains de microfilaries sanguicoles constituent le principal réservoir de parasites
- cependant les sujets neufs non autochtones font souvent des formes typiques.

CLINIQUE

2/ Formes symptomatiques:

- L'incubation souvent asymptomatique varie de 3 mois à 1 an.
- La phase d'invasion:
Asymptomatique ou avec des signes non spécifiques (prurit, éruption cutanée, arthralgies, œdème...)
- La phase d'état: correspond à la localisation des vers adultes dans le système lymphatique
 - Manifestations aiguës dues à l'inflammation,
 - Manifestations chroniques dues au blocage au niveau des vaisseaux lymphatiques.

CLINIQUE

➤ La phase aiguë : se manifeste par :

- une fièvre élevée
- lymphangites aiguës des membres à évolution centrifuge (de la racine vers l'extrémité des membres).
- accidents génitaux (lymphangite du scrotum, funiculite, orchite avec hydrocèle chyleuse)
- lymphangites aiguës profondes avec fièvre et douleurs thoraciques ou abdominales
- adénites aiguës superficielles: inguinales ou axillaires
- manifestations allergiques avec hypréosinophilie (très rares, Asie)

CLINIQUE

➤ **La phase chronique** Conséquence de l'obstruction des voies lymphatiques (10 à 20 ans)

- **Adénolymphocèle**: tumeur molle indolente traduit la stagnation de la lymphe (aine, scrotum, sein...)
- **Lymphoedème** (ou gonflement d'un membre),
- **Orchiépididymites** : chroniques et stérilisantes
- **Varices lymphatiques**
- **Chylolymphurie**: élimination de lymphe dans les urines (microfilaires)
- **Eléphantiasis** forme la plus avancée du lymphoedème : lésions dermo-hypodermiques, siégeant aux **membres inférieurs et supérieures, seins, aux organes génitaux externes : scrotum, verge, vulve, pénis ...**
- ❖ Ces accidents tardifs progressivement installés et spectaculaires sont invalidants, sources de surinfections et socialement difficiles à supporter.



Lymphoedème

CLINIQUE

➤ Forme allergique (forme particulière)

- **Syndrome d'éosinophilie tropicale** ou **filariose occulte** qui résulte d'une forte réponse immune dirigée contre les **microfilaires**;
- Touche les sujets récemment immigrés en zone d'endémie.



Eléphantiasis



DIAGNOSTIC AU LABO

➤ Éléments d'orientation

Le diagnostic d'orientation est basé sur :

- Notion de séjour en région d'endémie
- Présence de lymphangites et d'adénopathies
- Hyperéosinophilie
- l'imagerie médicale permet de visualiser les filaires adultes directement au sein des voies lymphatiques et d'apprécier leurs mouvements, donc leur **viabilité** (échographie scrotale avec le « dancing worm », ...).

DIAGNOSTIC

➤ Diagnostic de certitude

- La recherche des filaires adultes (exceptionnellement retrouvés) est déconseillée car elle fait courir le risque de poussées inflammatoires réactionnelles (ponction ou biopsie ganglionnaires).
- Le diagnostic de certitude est direct et basé sur la recherche quantitative et qualitative des microfilaires dans le sang

La recherche des microfilaires doit tenir compte de leur périodicité. le prélèvement sera effectué souvent entre: **22h-4h** pour les espèces nocturnes

- La prise de **100 mg de diéthylcarbamazine** une heure avant l'examen favorise la sortie des microfilaires dans le sang périphérique et permet de faire des prélèvements diurnes.

DIAGNOSTIC

- Examen direct :
 - **l'état frais** (repérage facile: mouvements des microfilaires)
 - **après coloration** sur: Frottis mince /Goutte épaisse: MGG
- En cas de négativité ,des techniques de concentration impliquant un prélèvement de sang veineux :

Méthodes de concentration :

- Technique de KNOTT:
- Leucoconcentration à la saponine
- Centrifugation en tubes capillaire

☐ Parfois, les microfilaires sont retrouvées dans le sédiment d'une urine chyleuse ou dans le liquide d'hydrocèle.

➤ Diagnostic immunologique

- Il est utilisé en cas d'absence de microfilaires et des vers adultes surtout au cours des **enquête épidémiologique**
- Les réactions immunologiques sont restreintes vu la rareté des antigènes homologues disponibles, les réactions croisées avec les autres filaires et les helminthes :
 - ✓ IFI ++, ELISA, électrosynérèse
 - ✓ Détection d'Ag circulant / AC monoclonaux;
 - ✓ ELISA: utilisation d'un AC monoclonale (Og4C3) détectant un Ag spécifique circulant de W.b
 - ✓ Test de diagnostic rapide par immuno-chrommatographie sur carte utilisant des Ac monoclonaux spécifiques d'Ag de W.b.

TRAITEMENT

- Symptomatique (antiinflammatoire...) en phase aiguë et ensuite parasitologique :
- Microfilaricides à dose croissante :
 - **Diéthylcarbamazine** ou Notezine®
 - **Ivermectine** ou Mectizan®
 - **Albendazole** ou Zentel®
- Il est peu efficace contre les filaires adultes.
- Le traitement des lésions tardives est le plus souvent **chirurgical**.

Prophylaxie

- **Collective** :

- Lutte anti vectorielle : insecticides, larvicides, destruction des gites larvaires.
- Lutte contre le réservoir du parasite (homme infesté) par chimiothérapie de masse

- **Individuelle** :

- Moustiquaires dans les zones à transmission
- Produits répulsifs
- Port de vêtements protecteurs (longs,...)

Onchocercose (cécité des rivières)

DEFINITION

C'est une filariose **cutanéodermique** due à *Onchocerca volvulus*.

Elle représente la deuxième cause mondiale de **cécité**.

La transmission à l'homme se fait par l'intermédiaire d'un insecte vecteur : **une simule**.

Elle concerne environ **30 millions** de personnes en Afrique occidentale, en Amérique latine et au Yémen où elle sévit à l'état endémique.

ÉPIDÉMIOLOGIE

2- Morphologie et biologie:

□ Les adultes:

- vers filiformes blanchâtres
- Le mâle: 2-3 Cm de long
- La femelle: 30-80 Cm de long,
- La durée de vie: 10- 15 ans
- Spécifique à l'homme
- vivent dans le derme (libres ou emprisonnés dans des nodules fibreux (**onchocercomes** ou kystes onchocerquiens)

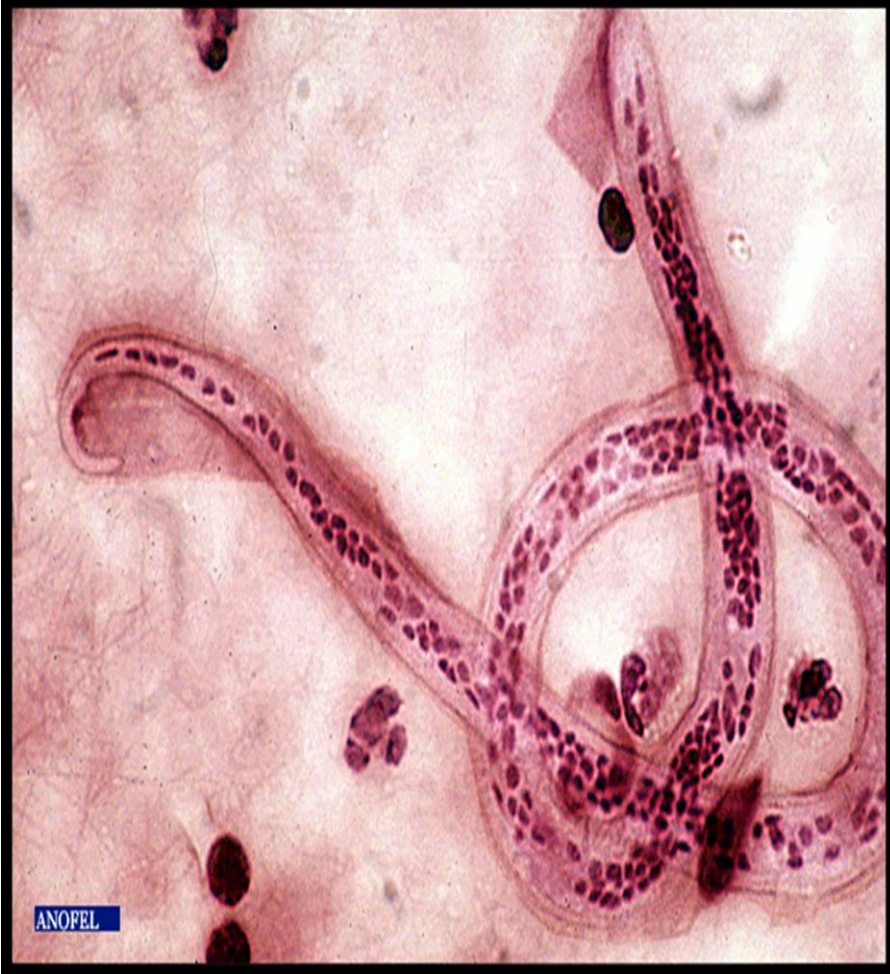
□ Microfilaires :

300 Um de long

gaine absente

Déplacement: dans le derme
(jour et nuit)

Survie: quelques mois



Microfilaire de *Onchocerca volvulus*



A female worm with the smaller male worm.

ÉPIDÉMIOLOGIE

3- Vecteur: La simulie

- Diptère nématocère
- Largement répandu dans le monde
- Un petit moucheron noir (1 à 3 mm)
- Reproduction près des rivières et des fleuves tropicaux.
- Seule la femelle est hématophage.
- Activité diurne (Elle pique à l'extérieur des maisons).



ÉPIDÉMIOLOGIE

4- Cycle évolutif:

Le cycle est indirect et fait intervenir l'homme (hôte définitif) et la simule femelle (hôte intermédiaire).

La simule s'infecte lors d'un repas sanguin en prélevant, dans le derme d'un malade, des microfilaires qui évoluent en larve L1, larve L2 dans les muscles thoraciques, puis en larve L3 qui migre vers le labium.

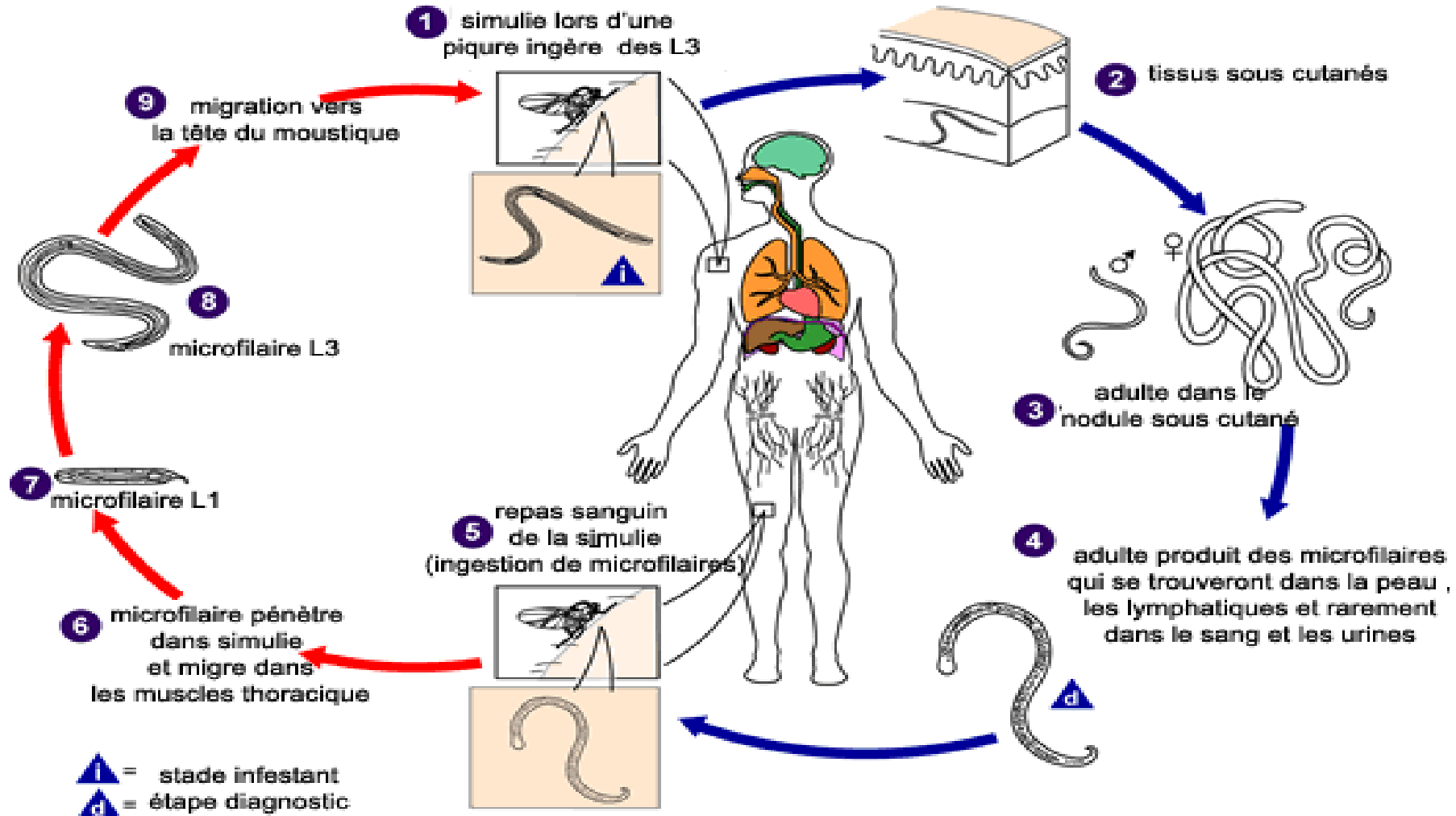
Ces larves sont déposées sur la peau d'un sujet et traversent activement l'épiderme au niveau du point de piqure. Elles migrent sous la peau, deviennent adultes et forment des nodules onchocerquiens.

Les microfilaires sont libérées de ces nodules et vont migrées dans le tissu sous cutané.

Onchocerca volvulus

cycle chez le moustique

cycle chez l'homme



Cycle évolutif d'*Onchocerca volvulus*

ÉPIDÉMIOLOGIE

5- Répartition géographiques:

- **Foyer africain** (du Sahel présaharien jusqu'en Angola et la Tanzanie) +++
- **Foyer américain** (Amérique centrale et de sud)
- **Foyer asiatique** (Yémen)



CLINIQUE

L'onchocercose souvent asymptomatique ou s'exprime par trois syndromes :

- **LE SYNDROME CUTANÉ :**

Lésions cutanées avec prurit, pachydermie, « gale filarienne », dépigmentation

- **LE SYNDROME KYSTIQUE :**

Onchocercomes, ou nodules onchocerquiens, indolores disséminés sur le corps.

- **LE SYNDROME OCULAIRE :**

Des lésions oculaires se manifestent après 10 à 15 ans d'évolution et sont dues à l'accumulation des **microfilaires** dans les yeux. Elles entraînent une **cécité totale**.

1) SYNDROME CUTANÉ



Gale filarienne



Pachydermie



Pseudo vitiligo onchocerquien(peau de léopard)



Le sowda

2) SYNDROME KYSTIQUE :

Nodules à onchocerque



3) Les atteintes oculaires

graves, tardives:

- **héméralopie**
- **Kératite**
- **Choriorétinite**
- **Cécité: +++**



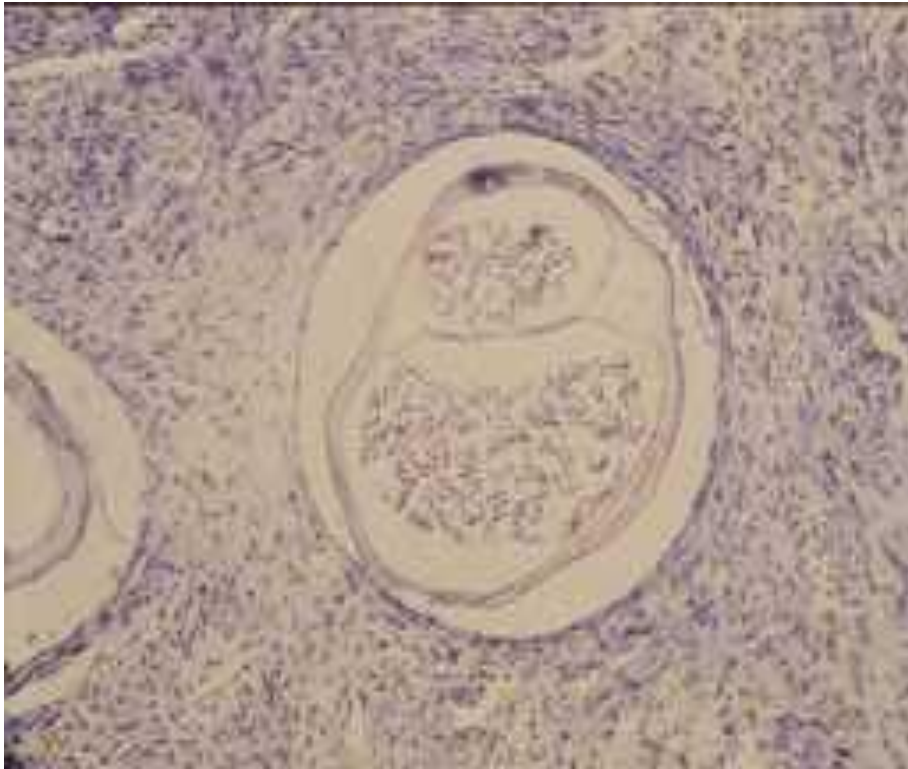
DIAGNOSTIC AU LABO

Diagnostic d'orientation: - Notion de séjour en région d'endémie - Hyperéosinophilie.

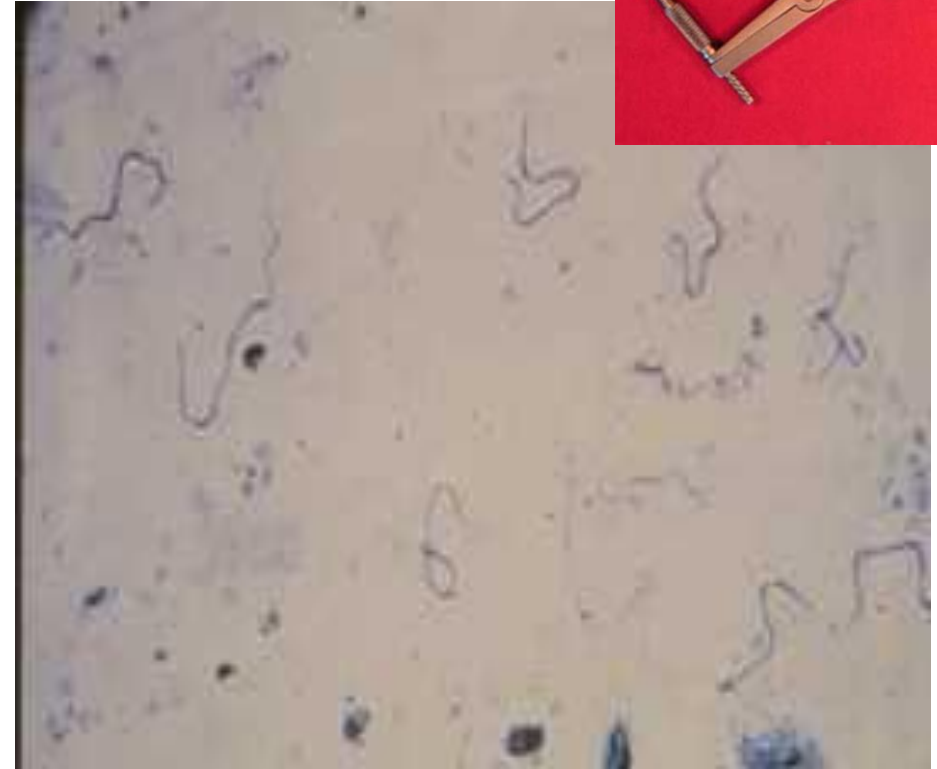
Diagnostic de certitude: la mise en évidence du parasite adulte ou de ses embryons

- La mise en évidence des **microfilaires** dans le derme, par:
 - scarification et examen du suc dermique,
 - Biopsie cutanée exsangue :précisant la « charge microfilarienne »
(indispensable au suivi thérapeutique et aux analyses épidémiologiques).
- La présence de **microfilaires** dans les urines et parfois dans le sang a été signalée, surtout à la suite de traitements spécifiques.
- la ponction d'un nodule peut ramener un liquide contenant des **microfilaires**.
- L'examen ophtalmologique permet d'observer les microfilaires dans la chambre antérieure de l'œil.
- Après nodulectomie, les **filaires adultes** sont facilement reconnaissables
- L'analyse histologique des onchocercomes permet de voir les **macrofilaires adultes**.

Diagnostic indirect repose sur la recherche d'anticorps sériques par ELISA ou par IFI.



Coupe anatomopathologique d'un nodule onchocerquien (adultes)



Recherche de microfilaries dans une biopsie cutanée exsangue



TRAITEMENT

Il est dirigé contre les microfilaires responsables des troubles cutanés et des lésions oculaires et plus difficilement contre les filaires adultes

- **Ivermectine:** (Traitement de choix) en prise unique qui, grâce à une action sur la jonction neuromusculaire des parasites, diminue la production des larves par les femelles.
- L'**ivermectine** associée à l'**albendazole** aurait une action sur les filaires **adultes** en cure unique particulièrement intéressante en campagne de masse.
- Autres: la **diéthylcarbamazine**

Prophylaxie

L'incidence socio-économique et le nombre élevé de malades aveugles ont depuis les années 1970 motivé d'importantes enquêtes et campagnes de masse :

L'« Onchocerciasis Control Program » d'abord fondé sur une **lutte antivectorielle** (larvicides) s'est progressivement modifié en y associant une distribution communautaire annuelle de microfilaricides (Mectizan®, Zentel®, ...) empêchant la transmission au vecteurs (« African Program Onchocerciasis Control » 1995).

Loase à *Loa loa*

DEFINITION

La filariose à *Loa loa*, ou loase, ou loase, est une helminthiase, cutanée par la localisation des vers adultes, et sanguicole par celle des embryons ou microfilaires.

Elle est strictement africaine et transmise par un taon appartenant au genre *Chrysops*.

Habituellement bénigne avec certains signes cliniques spectaculaires , mais peut évoluer occasionnellement vers des complications viscérales.

Environ 13 millions de personnes sont infestées en forêt tropicale.

ÉPIDÉMIOLOGIE

2- Morphologie et biologie

- ☐ Les adultes sont des vers blanchâtres, mesurent 2 à 7 cm de long et vivent sous la peau.
- ☐ La durée de vie du ver adulte est d'environ 10 à 15 ans.
- ☐ Les microfilaires (300 μ m) vivent dans le sang périphérique.
- ☐ Microfilarémie de périodicité diurne.



Loa loa microfilaires



Loa loa macrofilaires (adulte)



ÉPIDÉMIOLOGIE



3- Vecteur:

Le vecteur est un diptère de la famille des **Tabanidae** appartenant au genre **Chrysops** ou **mouche rouge**.

- Seules les femelles sont hématophages.
- Leur piqure est diurne et douloureuse.
- Il est strictement africain et abondant dans les zones forestières chaudes et humides d'Afrique équatoriale de l'Ouest.

ÉPIDÉMIOLOGIE

4- Cycle évolutif: indirect

Homme: hôte définitif / Chrysops femelle:hôte intermédiaire.

Les microfilaires sont absorbées lors de la piqûre du Chrysops d'un sujet infecté. Elles évoluent en larves L1 puis en larve L2 dans les muscles thoraciques puis en larve L3 avant de migrer vers le labium.

Ces larves sont déposées sur la peau d'un sujet sain puis vont pénétrer activement par la blessure causée par la piqûre. Elles migrent sous la peau, deviennent adultes en 3 mois.

les femelles pondent des microfilaires qui gagnent les capillaires périphériques et elles seront absorbées lors d'une piqûre ultérieure.

ÉPIDÉMIOLOGIE

5- Répartition géographiques:

La loase est **strictement africaine**, surtout équatoriale et occidentale, limitée à la grande forêt.



Afrique centrale de l'ouest

CLINIQUE

- Incubation: (3 mois) silencieuse, s'accompagnant d'une hyperéosinophilie.
- trois symptômes peuvent survenir : sporadiques, isolés ou groupés:
 1. Le signe pathognomonique est l'**œdème de Calabar** localisé surtout à la face ou aux membres supérieurs. Il est éphémère, migrateur et allergique.
 2. **La reptation du ver sous la peau** sous forme d'un cordon palpable, mobile, se déplaçant de 1cm/min, entraînant un prurit, un fourmillement et un abcès en cas de la mort du ver.
 3. **Le passage du ver adulte sous la conjonctive**: bénin et fréquent, provoquant une photophobie avec des larmoiements et une gêne de la vision.
- Complications:

neurologiques (hémiplégie, encéphalite), cardiaques (insuffisance cardiaque, endocardite) et rénales (protéinurie).



Œdème de Calabar, allergique fugace et migrateur pathognomonique de la filariose à *Loa loa*.



Migration sous conjonctivale d'une filaire adulte de *Loa loa*

DIAGNOSTIC AU LABO

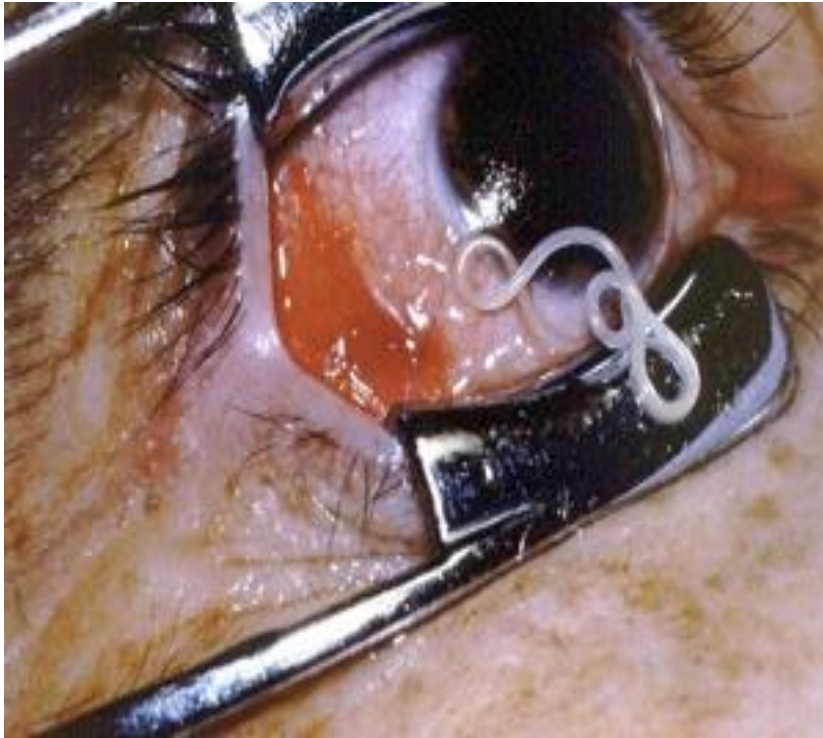
Diagnostic d'orientation

- Notion de séjour en région d'endémie – Hyperéosinophilie +++ - des œdèmes récidivants

Diagnostic de certitude: repose sur

- **La mise en évidence des microfilaires** dans le sang à l'état frais ou après coloration d'un frottis mince ou d'une goutte épaisse ou bien dans le culot d'une leucoconcentration (en cas de pauci parasitisme).
 - Le prélèvement doit être effectué de jour entre 11 h et 13 h. périodicité diurne
 - La détermination de l'espèce est plus délicate ;
 - Une numération des microfilaires est indispensable avant le traitement.
- **La mise en évidence de la macrofilaire** repérée lors de son passage sous les téguments ou lors de son cheminement sous-conjonctival. Son extraction se fait à l'aide d'un vaccino-stylet, d'une pince fine ou après scarification.

Diagnostic indirect La recherche d'anticorps est indiquée chez les sujets présentant des manifestations cliniques évocatrices sans microfilarémie



Extraction de l'adulte de Loa loa. lors de son assage sous-conjonctival

TRAITEMENT

- Le traitement de la loase est dangereux (risque d'effets indésirables, parfois mortels surtout si le sujet est fort porteur de microfilaires) et doit être conduit en milieu hospitalier spécialisé

Il repose sur la **diéthylcarbamazine, ou Notézine®**.

à prescrire à doses très progressivement croissantes accompagnées d'antihistaminiques ou de corticoïdes.

- L'exsanguinotransfusion ou, mieux, l'hémodilution constituent des alternatives thérapeutiques d'exception
- L'ivermectine (Mectizan®) utilisée en cure unique annuelle est un excellent microfilaricide , mais peu actif sur les adultes.

Prophylaxie

La prophylaxie consiste à éviter les piqûres du taon par le port de vêtements longs car la lutte contre ces insectes est difficile (gîtes larvaires inaccessibles) et les insecticides sont souvent inefficaces.

En zone d'endémie, il peut être conseillé de prendre un demi-comprimé deux fois par semaine de **diéthylcarbamazine** (résident temporaire mais inutile chez l'autochtone)

MERCI DE VOTRE
ATTENTION